

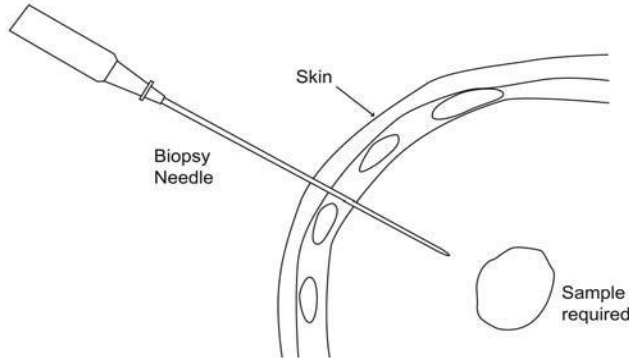
Consent Information - Patient's Copy
Biopsy under Medical Imaging Guidance

معلومات الإقرار – نسخة المريض
الحصول على خزعة (عينة) مع استخدام التصوير

1. What is a Chest Biopsy?

A biopsy (also known as a 'Core Biopsy' or 'Fine Needle Aspiration' – FNA) is the removal of a sample of tissue, cells or fluid from the body. The sample is sent to pathology for testing.

Biopsies performed in medical imaging are done with guidance from imaging machines such as ultrasound or CT.



2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure may require the injection of a local anaesthetic. It is used to prevent or relieve pain, but will not put you to sleep. A sedative injection is rarely given. You should feel no more than mild discomfort.

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful. You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

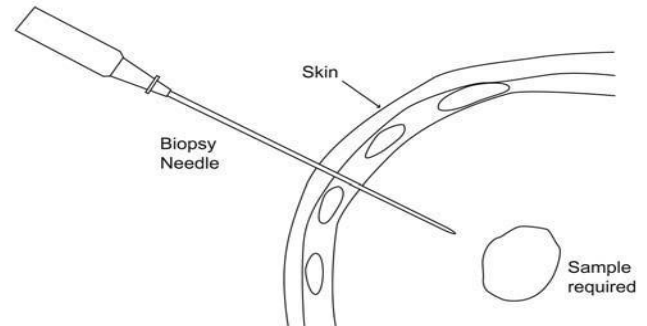
The type of anaesthetic may depend on your need to be able to co-operate at times when instructed by the doctor e.g. when required to hold your breath.

Sedation is generally very safe but has a risk with side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- whether you have any other illness
- personal factors, such as whether you smoke or are overweight.

1. ما هو إجراء أخذ خزعة (عينة) من الصدر؟
 الحصول على العينة (تسمى أيضاً "عينة اللب أو الجوهر" أو "العينة المسحوبة باستخدام إبرة دقيقة") هو إزالة عينة من النسيج، الخلايا أو السوائل من الجسم. يتم إرسال العينة إلى مختبر علم الأمراض لفحصها. في حالتك، سيتم أخذ العينة من صدرك. يتم أخذ العينات في قسم التصوير الطبي تحت توجيه من أجهزة تصوير مثل جهاز الموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي المحوسب. للمزيد من المعلومات عن وسائل التصوير المستخدمة والمخاطر المتعلقة بها، نرجو قراءة ورقة معلومات المريض المتعلقة بالتصوير المقطعي أو الموجات فوق الصوتية (إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها).



2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
 يتطلب الإجراء حقنة مخدر موضعي. غرض الحقنة هو منع الشعور بالألم أو علاجه، ولكنها لن تتسبب في نومك.

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟
 هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء.

في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف. من المهم أن تكون أن تكون قادراً على التجاوب التام مع الطبيب عندما يطلب منك حبس النفس.

التخدير بشكل عام آمن، إلا أن كل دواء مخدر له مخاطره وآثاره الجانبية ومضاعفاته، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى.
- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

4. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- You will be told when to have your last meal and drink. This is to make sure your stomach is empty so that if you vomit during the procedure there will be nothing to go into your lungs.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant.
- If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.
- List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit, please tell your doctor.

5. During the procedure

A fine needle (IV cannula) may be inserted into a vein in your arm.

Pictures will be taken of the biopsy site. The doctor may inject a local anaesthetic.

Using imaging as a guide the doctor will insert the biopsy needle. The biopsy is taken and the needle removed. It is not unusual for this step to be repeated.

You must remain as still as possible. At times, you may be asked to hold your breath.

At the end of the procedure, a dressing will be applied to the puncture site.

6. After the procedure

In the case of chest biopsy you will have a chest x-ray after the procedure. This is to make sure that you do not have an air leak around your lungs.

The recovery time varies depending on the biopsy site and the sedation that may have been given. It varies between 2 hours to 6 hours.

The IV cannula if used will be removed after you have recovered.

Staff will discuss with you what level of activity is suitable after your procedure.

7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula if used. This may require treatment with

4. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- سيتم إبلاغك بآخر موعد يمكنك فيه تناول الطعام والشراب لأنه من المهم أن تكون معدتك فارغة أثناء الفحص ، لتلافي أي تقيؤ قد يؤدي إلى دخول المادة المتبقية إلى الرئتين.
- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً .
- إن كنت تتناول أيًا من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو دايبيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

5. أثناء الإجراء

قد توضع إبرة صغيرة في أحد أورد ذراعك (الخط الوريدي).
تؤخذ صور لموقع العينة.

يحقن الطبيب المخدر الموضعي.

باستخدام التصوير كأداة للتوجيه ، يقوم الطبيب بإدخال إبرة أخذ العينة.
تؤخذ العينة وتزال الإبرة المستخدمة في ذلك. قد تتم إعادة هذه المرحلة من الإجراء.

حاول أن لا تتحرك وأن تحافظ على سكونك قدر الإمكان. قد يطلب منك في بعض مراحل الفحص أن تحبس أنفاسك.
في نهاية الإجراء ، يوضع الضماد على الموضع الذي تم إدخال الإبرة منه.

6. بعد الانتهاء من الإجراء

سيتم أخذ أشعة سينية للصدر بعد 2-4 ساعات من نهاية الإجراء وذلك للتأكد من عدم وجود تسرب للهواء حول الرئتين.

فترة النقاهة بعد الإجراء تتوقف على الموضع الذي أخذت منه العينة والدواء المسكن إن كان قد أعطي لك ، وتتراوح ما بين 2-6 ساعات.

بعد النقاهة ، تزال إبرة الخط الوريدي.

سيناقش معك الموظفين الذين أجروا الفحص لك مقدار الأنشطة التي يمكنك ممارستها بعد الأجراء

7. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم بسيط ، كدمة و \ أو عدوى بسبب إدخال الخط الوريدي. قد تتطلب معالجة بالمضادات الحيوية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

antibiotics.

- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- In the case of chest biopsy coughing up blood, small (teaspoon size) amounts, this usually resolves by itself.
- In the case of chest biopsy pneumothorax (small) a collection of air around the lining of the lungs. This usually stops by itself but sometimes may require a tube to be inserted into the chest.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- In the case of chest biopsy pneumothorax (large) a collection of air around the lining of the lungs. This usually stops by itself but sometimes may require a tube to be inserted into the chest.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The biopsy procedure may not obtain enough tissue and may need to be repeated at a later date.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- In the case of chest biopsy an air bubble enters the blood stream from the lung. This can travel to the heart causing a heart attack or to the brain causing a stroke.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment

- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة العينة. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة. وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- سعال مصحوب بخروج دم (كمية الدم بسيطة تعادل مقدار ملعقة الشاي). يتعافى ذلك عادةً تلقائياً.

- وجود تجمع صغير للهواء حول بطانة الرئة وهو ما يسمى بـ (استرواح الصدر). عادةً ما يتوقف ذلك من تلقاء نفسه، إلا أنه أحياناً تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب في الصدر.

- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.

- ضرر لعصب. غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.

- وجود تجمع كبير للهواء حول بطانة الرئة وهو ما يسمى بـ (استرواح الصدر). عادةً ما يتوقف ذلك من تلقاء نفسه، إلا أنه أحياناً تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب في الصدر.

- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.

- نزيف مفرط من موضع دخول إبرة العينة. قد يتطلب ذلك علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.

- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.

- الإجراء قد لا تنتج عنه الكمية الكافية من الأنسجة وقد تكون هنا حاجة لإعادته في موعد آخر.

- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- فقاعة هواء قد تدخل مجرى الدم من الرئة. قد تنتقل هذه الفقاعة إلى القلب مسببة أزمة قلبية، أو إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم.
- غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Stroke resulting in brain damage.

8. What are the safety issues when you leave the hospital?

If you were sedated, this will affect your judgment for about 24 hours. For your own safety:

- Do **NOT** drive any type of car, bike or other vehicle.
- Do **NOT** operate machinery including cooking implements.
- Do **NOT** make important decisions or sign a legal document.
- Do **NOT** drink alcohol, take other mind-altering substances, or smoke. They may react with the anaesthetic drugs.
- Have an adult with you on the first night after your procedure.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

إذا كنت قد تلقيت دواءً مسكناً ، فإنه قد يؤثر لحوالي 24 ساعة على قدرتك في اتخاذ القرار. لضمان سلامتك :

- لا تقد أي نوع من المركبات كالسيارة أو الدراجة أو غيرها. يجب أن يرافقك إلى المنزل شخص عاقل بالغ ومسؤول عند خروجك من المستشفى.
- لا تقم بتشغيل أي آلات بما في ذلك أدوات الطهي.
- لا تتخذ أي قرار مهم ولا تقم بتوقيع أي مستند قانوني.
- لا تحتسي الكحول أو تتناول أي من المواد المسببة للهلوسة ، ولا تدخن . كل ذلك قد يتفاعل مع الدواء المسكن.
- استعن بشخص بالغ بظل بجوارك في الليلة الأولى بعد الإجراء.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي :
